NEDEĽNÁ METAFYZIKA

# Metafyzika 4

Hranice pomoci, autonómia a dôvera v medicíne

---

Hranice medicíny a sloboda pacienta
Odmietnutie a odvolanie súhlasu
Popieranie rozhovoru a nepriateľské správanie
Úloha rodiny, dôvera a zodpovednosť
Konečnosť života a pokračovanie starostlivosti

**Starostlivosť bez opustenia. Pomoc bez privlastnenia.**

Filozofický a klinicko-etický spis

Slovenské vydanie / štvrtý diel / nedeľa 25. októbra 2026

Pripravené pre Ľubomíra Polaščína

**Orientácia v spise**

# Obsah

Štvrtý diel série Nedeľná metafyzika. Každá kapitola rozvíja jednu časť problému; osobitný priestor má zmena súhlasu a konflikt po popretí predchádzajúceho rozhovoru.


| | |
|---|---|
| Keď pomoc naráža na slobodu | 3 |
| Čo znamená pacientovi pomôcť? | 4 |
| Štyri hranice medicíny | 5 |
| Za jedným odmietnutím môže byť viac príbehov | 6 |
| Schopnosť rozhodovať nie je poslušnosť | 7 |
| Ako dlho presviedčať? | 8 |
| O dva dni: popretý rozhovor a nový odpor | 9 |
| Čo môže znamenať popieranie? | 10 |
| Má pacient povinnosť odhaliť svoje dôvody? | 11 |
| Nepriateľstvo a rozpad dôvery | 12 |
| Ako obnoviť rozhodovanie po konflikte | 13 |
| Dokumentácia bez čítania myšlienok | 14 |
| Ohrozenie života neruší všetky hranice | 15 |
| Rodina: blízkosť nie je automatická právomoc | 16 |
| Keď blízki pomoc odmietajú | 17 |
| Prečo je pojem pasívna eutanázia nepresný | 18 |
| Úľava nie je opustenie | 19 |
| Tri situácie, tri odlišné rozhodnutia | 20 |
| Komu patrí život? | 21 |
| Tá istá osoba, iná vôľa | 22 |
| Sloboda zraniteľného človeka | 23 |
| Zodpovednosť nie je všemocnosť | 24 |
| Postup pri akútnom konflikte | 25 |
| Čo zostáva sporné? | 26 |
| Zostať bez privlastnenia | 27 |
| Slovníček a hranice interpretácie | 28 |
| Pramene a odborné podklady | 29-30 |


Vydanie na nedeľu 25. októbra 2026. Text a pramene pripravené a skontrolované 24. októbra 2026. Modelové situácie neidentifikujú konkrétnych pacientov.

Úvod

# Keď pomoc naráža na slobodu

Lekár môže vedieť, ako odvrátiť smrť, a predsa nemať oprávnenie uskutočniť navrhovaný výkon. Vtedy sa neukazuje iba hranica medicíny. Ukazuje sa aj hranica našej moci nad druhým človekom.

## Záchrana nie je vlastníctvo

Povinnosť pomáhať je základom medicíny. Nie je však neobmedzeným právom určiť pacientovi, čo musí pokladať za dobro. Pacient nie je orgánový systém, ktorý sme prevzali do správy. Je človekom s vlastnou skúsenosťou, vzťahmi, strachom a predstavou prijateľného života.

## Ústredná otázka

Ako dlho máme presviedčať človeka, ktorý odmieta účinnú liečbu? Čo robiť, ak sa rodina nezapája? A čo znamená, keď pacient po dvoch dňoch poprie predchádzajúci rozhovor, odvolá súhlas a reaguje nepriateľsky? Tieto situácie nemožno vyriešiť ani automatickým ustúpením, ani presadením liečby za každú cenu.

## Tri roviny jedného problému

Spis odlišuje filozofickú úvahu, klinicko-etické odporúčania a slovenský právny rámec. Metafyzická interpretácia môže objasniť naše chápanie osoby, slobody a konečnosti. Nemôže však nahradiť posúdenie aktuálneho stavu ani právne oprávnenie na konkrétny zásah. Medzinárodné odporúčania tu slúžia ako odborné podklady, nie ako slovenské zákony.

## Východisko

Treba urobiť dosť, aby odmietnutie nebolo dôsledkom neporozumenia, zanedbanej poruchy rozhodovania alebo nedostupnej pomoci. Zároveň nemožno pokračovať tak, aby výsledný súhlas vznikol zlomením pacientovej vôle. Odmietnutie jedného výkonu navyše neznamená odmietnutie všetkej starostlivosti.

> **Nosná téza**
> Keď sa skončí oprávnenie presadzovať určitú liečbu, nekončí sa povinnosť starať sa o človeka.

I. Hranice pomoci

# Čo znamená pacientovi pomôcť?

Medicínske zlepšenie a dobrý život spolu súvisia, ale nie sú totožné. Laboratórny výsledok nám nepovie všetko o tom, čo liečba znamená pre človeka.

## Päť odlišných otázok

Najprv sa pýtame, či dokážeme zasiahnuť. Potom, či zásah pravdepodobne pomôže, či jeho prospech vyvažuje záťaž a či zodpovedá pacientovým cieľom. Až s tým súvisí posledná otázka: smieme ho vykonať? Technická možnosť, medicínska indikácia, primeranosť a súhlas sa nesmú zlúčiť do jediného úsudku.

## Krátkodobý cieľ a celkový zmysel

Dialýza môže odstrániť život ohrozujúcu poruchu vnútorného prostredia. Nemusí však obnoviť funkčný stav, ktorý si pacient predstavuje. Naopak, prechodná záťaž môže umožniť návrat k životu, ktorý pacient chce, len túto súvislosť zatiaľ nevidí. Úlohou rozhovoru je ukázať realistické možnosti, nie sľúbiť výsledok, ktorý nevieme zaručiť.

## Komu patrí hodnotenie záťaže?

Lekár má odbornú autoritu pri hodnotení účinku a rizika. Pacient má nezastupiteľnú skúsenosť s tým, čo preňho znamená bolesť, závislosť od pomoci, opakovaná hospitalizácia či strata súkromia. Ani jedna perspektíva sama nestačí. Pacient nemusí vedieť odhadnúť prognózu; lekár nemusí poznať cenu liečby v jeho každodennom živote.

## Pomoc aj bez vyliečenia

Pomôcť možno aj obnovením orientácie, zmiernením dýchavice, zabezpečením dopravy alebo vytvorením priestoru na rozhovor bez rodinného nátlaku. Aj po definitívnom rozhodnutí nepodstúpiť výkon zostáva priestor na ošetrovateľskú starostlivosť, liečbu príznakov, psychickú podporu a bezpečný plán ďalšej starostlivosti. [1, 3, 7]

> **Rozlíšenie**
> Účinná liečba môže byť platne odmietnutá. Odmietnutá liečba sa tým nestáva neúčinnou ani medicínsky márnou.

I. Hranice pomoci

# Štyri hranice medicíny

Niektoré hranice sa dajú posúvať výskumom a lepšou organizáciou. Iné vyplývajú zo samotnej povahy ľudskej existencie a vzťahu medzi ľuďmi.

## Hranica poznania

Rozhodujeme sa pri neistote. Vieme pomenovať vysoké riziko smrti, ale často nevieme presný čas ani konečný výsledok. Poučenie má byť dôrazné aj poctivé. Veta, že pacient môže zomrieť, sa nesmie bez podkladu zmeniť na tvrdenie, že určite zomrie ešte dnes. Neistota však nie je dôvodom nebezpečenstvo zamlčať.

## Hranica účinnosti

Nie každý fyziologický účinok prináša celkový prospech. Pri slove márnosť treba vždy doplniť cieľ: čo liečba nedokáže dosiahnuť? Je iné znížiť koncentráciu draslíka a iné obnoviť vedomie pri nezvratnom poškodení mozgu. Prognóza, uskutočniteľnosť a primeranosť sa musia hodnotiť oddelene.

## Hranica oprávnenia

Aj dobre indikovaný výkon môže naraziť na platné odmietnutie. Povinnosť poskytovať správnu zdravotnú starostlivosť nemožno vykladať oddelene od požiadavky informovaného súhlasu a zákonných výnimiek. Odborná pravda o prospešnosti výkonu sama nedáva moc nad cudzím telom. [1, § 4 a § 6]

## Hranica konečnosti

Život nemožno zachovať navždy. Smrť môže byť následkom zanedbania, ale nie každá smrť je zlyhaním zdravotníkov. Aj predlžovanie umierania bez primeraného prospechu môže znamenať stratu správneho cieľa. Hodnota osoby sa nezvyšuje počtom výkonov a neznižuje tým, že už nedokážeme predĺžiť jej život.

> **Otázka na premýšľanie**
> Chránime pacientov život, alebo sa usilujeme dokázať, že medicína ešte nestratila kontrolu?

II. Rozhodovanie pacienta

# Za jedným odmietnutím môže byť viac príbehov

Tvrdohlavosť je pomenovanie nášho zážitku z rozhovoru. Nie je vysvetlením pacientovho konania ani diagnózou.

## Čo presne pacient odmieta?

Odmietnuť dialýzu, zavedenie katétra, prevoz, hospitalizáciu či liečbu na konkrétnom pracovisku neznamená rozhodnúť sa zakaždým o tom istom. Pacient môže chcieť liečbu, ale nie spôsob, ktorý mu ponúkame. Môže nesúhlasiť iba s dnešným termínom alebo sa obávať, že jednorazovým súhlasom prijíma celoživotný záväzok. Najprv treba spresniť predmet nesúhlasu.

## Strach, skúsenosť a nedôvera

Za odporom môže byť bolesť z predchádzajúceho výkonu, skúsenosť s ponížením, obava z nákladov či predstava nezvratnej závislosti. Niekedy pacient neverí pravdivému vysvetleniu, pretože inému zdravotníkovi dôveroval a sklamal sa. Argumentovať iba ďalšími číslami potom nemusí byť účinné. Chýba dôvera potrebná na prijatie informácie.

## Porucha rozhodovania

Nová zmätenosť, nepozornosť, porucha pamäti, hypoxia, metabolická encefalopatia alebo účinok liekov môžu rozhodovanie narušiť. Ich prítomnosť treba skúmať; nemožno ju vyvodiť iba z nesúhlasu. Rovnako nemožno prehliadnuť delírium len preto, že pacient zrozumiteľne povie nie. [4, 6]

## Odlišné hodnoty

Niektorý pacient rozumie a napriek tomu odmieta. Môže pripisovať inú váhu dĺžke života a záťaži liečby. Lekár má právo jeho úvahu skúmať a odporúčanie obhájiť. Nemá právo uznať za skutočné rozhodnutie iba to, ktoré zodpovedá jeho vlastnej hierarchii hodnôt.

> **Lepšia prvá otázka**
> Čo sa pacient usiluje odmietnutím ochrániť a čo by sa muselo zmeniť, aby preňho bola liečba prijateľná?

II. Rozhodovanie pacienta

# Schopnosť rozhodovať nie je poslušnosť

Rozumné rozhodovanie nemožno definovať tak, aby ním bol iba súhlas s lekárom. Takéto meradlo by autonómiu priznávalo len tým, ktorí ju nepoužijú proti nášmu odporúčaniu.

## Konkrétne rozhodnutie a konkrétny čas

V klinickej praxi sa schopnosť rozhodovať posudzuje vo vzťahu ku konkrétnemu rozhodnutiu a aktuálnemu stavu pacienta. Nie je totožná s celkovou inteligenciou, orientáciou, psychiatrickou diagnózou ani spôsobilosťou na právne úkony. Pacient môže byť orientovaný a predsa nedokázať primerane spracovať podstatné následky konkrétneho rozhodnutia.

## Čo treba overiť

Užitočné je overiť, či pacient rozumie informáciám, dokáže si ich uchovať dostatočne dlho na rozhodnutie, vie vztiahnuť následky na seba, zvážiť možnosti a vyjadriť svoju voľbu. Ide o klinickú syntézu príbuzných odborných rámcov. Nie je to doslovný zákonný test platný na Slovensku. Britské odporúčania NICE treba čítať s vedomím ich vlastného právneho prostredia. [4]

## Vlastnými slovami

Namiesto otázky, či pacient rozumel, ho požiadame, aby opísal svoj stav, očakávaný účinok liečby a riziko jej nepodstúpenia. Overovanie nie je skúškou odborného názvoslovia. Má ukázať, či vie informáciu použiť pri vlastnom rozhodnutí. Samotný kognitívny skríning ani plynulá reč na toto posúdenie nestačia.

## Riziko vyžaduje dôkladnosť

Čím závažnejší je následok, tým dôkladnejšie má byť posúdenie, podpora a dokumentácia. Neznamená to zvyšovať požiadavky dovtedy, kým ich splní iba súhlasiaci pacient. Diagnóza depresie, renálneho zlyhania či demencie sama osebe nedokazuje neschopnosť rozhodovať.

> **Základná ochrana**
> Treba opísať konkrétne narušenú schopnosť a jej súvislosť s rozhodnutím. Nesúhlas sám takýmto opisom nie je.

II. Rozhodovanie pacienta

# Ako dlho presviedčať?

Nie až do získania pacientovho súhlasu. Má zmysel pokračovať, kým ďalší rozhovor môže zlepšiť jeho porozumenie, posilniť slobodu rozhodovania alebo rozšíriť možnosti, ktoré má k dispozícii.

## Pokračovanie má mať nový obsah

Opätovný rozhovor je odôvodnený, ak sa dá odstrániť nedorozumenie, zmierniť bolesť, doplniť alternatíva alebo obnoviť pozornosť. Pomôcť môže tlmočenie, načúvací prístroj, súkromie či iný člen tímu. Nové klinické okolnosti tiež vyžadujú nové vysvetlenie. [5]

## Počet rozhovorov nie je morálne meradlo

Neexistuje univerzálna hranica dvoch, troch či piatich pokusov. Viac rozhovorov môže znamenať starostlivosť aj nátlak. Rozhoduje ich obsah, načasovanie a vplyv na pacienta. Keď pacient rozumie a slobodne odmieta, opakovanie rovnakých argumentov až do vyčerpania nepodporuje jeho autonómiu.

## Jasné odporúčanie je prípustné

Lekár nemusí predstierať, že možnosti sú rovnako bezpečné. Môže jednoznačne odporučiť liečbu a pravdivo uviesť riziko smrti. Nátlakom sa stáva vyhrážanie opustením, nepravdivé strašenie, zahanbovanie alebo využitie závislosti pacienta od personálu. Slovenský zákon vyžaduje poučenie bez nátlaku. [1, § 6 ods. 2]

## Keď sa cieľ rozhovoru zmení

Po platnom odmietnutí sa pozornosť presúva k tomu, čo pacient prijíma, ako zvládnuť symptómy a ako postupovať pri zmene stavu. Rozhodnutie sa môže znovu otvoriť pri nových informáciách alebo na pacientovu žiadosť. Nemá sa z neho stať každodenný súboj o autoritu.

> **Kontrolná otázka lekára**
> Pomáham pacientovi rozhodnúť sa, alebo sa usilujem dosiahnuť, aby prestal odporovať?

III. Keď sa súhlas zmení

# O dva dni: popretý rozhovor a nový odpor

Náhla zmena postoja je dôvodom na nové posúdenie. Nie je sama osebe dôkazom klamstva, duševnej poruchy ani neplatnosti odmietnutia.

## Najprv oddeliť tri výroky

Pacient môže tvrdiť, že rozhovor vôbec neprebehol; môže si ho nepamätať; alebo môže povedať, že dnes nesúhlasí. Ide o odlišné tvrdenia. Spor o minulosť nesmie zakryť otázku, čo chce teraz a či je schopný o tom rozhodnúť. Aktuálne odmietnutie je potrebné posúdiť aj vtedy, keď je predchádzajúci súhlas dobre zdokumentovaný.

## Čo v skutočnosti pozorujeme

Vieme zaznamenať, že pacient popiera poučenie, odmieta výkon, zvyšuje hlas alebo odmieta uviesť dôvod. Tvrdenie, že zjavne zatajuje skutočnú motiváciu, už obsahuje interpretáciu. Môže byť správna, ale na základe opísaného správania ju nemožno považovať za istú. Aj pri silnom podozrení treba odlíšiť fakt, pacientovo vyjadrenie a náš úsudok.

## Súhlas nie je dlh voči lekárovi

Predchádzajúci súhlas neoprávňuje vykonať výkon napriek dnešnému platnému odmietnutiu. Pacient môže súhlas odvolať; § 6 ods. 8 to výslovne pripúšťa. Podpis dokladá určitý okamih rozhodovania, nie trvalé odovzdanie kontroly nad telom. Ak sa výkon už začal, bezpečný postup pri jeho ukončovaní treba posúdiť osobitne. [1]

## Čas mení aj samotného rozhodujúceho

Za dva dni sa môže zmeniť stav, informácia, tlak rodiny aj vnútorná ochota. Osoba zostáva tou istou osobou, ale jej vôľa nie je navždy uzamknutá v jednej chvíli. Zdravotníci zároveň nemusia ignorovať rozpor. Majú ho preveriť bez toho, aby ďalšiu pomoc podmieňovali tým, že pacient prijme ich verziu minulosti.

> **Prvý záver**
> Minulý súhlas je dôležitý údaj. Nie je to oprávnenie obísť dnešné odmietnutie ani dôkaz, že dnešná zmena musí byť neautentická.

III. Keď sa súhlas zmení

# Čo môže znamenať popieranie?

Rovnaká veta môže mať rozdielny pôvod. Diferenciálna úvaha má chrániť pred podcenením ochorenia aj pred neoprávneným obvinením.

### Informácia sa vôbec nemusela uložiť

Pacient mohol počas pôvodného rozhovoru prikyvovať, ale byť nepozorný, vyčerpaný, pod účinkom liekov alebo v začínajúcom delíriu. Ak si pacient neskôr na rozhovor nespomína, vzniká otázka, nakoľko mu vtedy porozumel. Samotná neprítomnosť spomienky však spätne nedokazuje, že súhlas bol neplatný. Treba preveriť vtedajší stav a obsah záznamu.

### Dnešná pamäť môže byť narušená

Náhle zmeny v priebehu hodín či dní, kolísanie pozornosti a zmeny spánkového rytmu, komunikácie alebo správania sú dôvodom myslieť na delírium. V nefrológii sa pridávajú možné metabolické a liekové príčiny. Aktuálne odporúčania NICE uvádzajú podľa prostredia skríning pomocou nástroja 4AT, prípadne nástrojov CAM-ICU alebo ICDSC; výsledok však nenahrádza celkové klinické posúdenie ani posúdenie rozhodovacej schopnosti. [6]

### Odlišná spomienka alebo odlišný význam

Pacient si môže pamätať ponuku, kým tím si pamätá dohodu. Prikývnutie môže znamenať porozumenie, nie prijatie výkonu. Môže si zameniť rozhovor o dočasnej liečbe s rozhovorom o dlhodobom programe. Aj zdravotníci si môžu časom spomienku neúmyselne zjednodušiť. Dobrý záznam pomáha; nie je však dôkazom neomylnosti každej interpretácie.

### Obrana, hanba alebo vedomé skreslenie

Popretie môže chrániť pred hanbou zo zmeny názoru, strachom alebo pocitom záväzku. Možné je aj vedomé skresľovanie udalosti. Z tejto možnosti však nevzniká diagnóza osobnosti ani právo odoprieť starostlivosť. Aj človek, ktorý nehovorí pravdu o minulosti, môže byť schopný platne rozhodnúť o dnešnom výkone.

> **Čo neprehliadnuť**
> Novú zmenu správania treba klinicky vysvetľovať skôr, než ju uzavrieme ako povahový problém. Príjemné vystupovanie však tiež nie je dôkazom zachovanej rozhodovacej schopnosti.

III. Keď sa súhlas zmení

# Má pacient povinnosť odhaliť svoje dôvody?

Rozhovor sa zlepšuje, keď poznáme motiváciu. Z toho ešte nevyplýva právo vynútiť si úplné vysvetlenie pacientovho vnútorného života.

## Súkromie má význam aj pri odmietnutí

Pacient nemusí lekárovi sprístupniť všetky rodinné konflikty, náboženské obavy, hanbu či osobné hodnoty. Neochota hovoriť môže sťažiť posúdenie, no sama nedokazuje neschopnosť rozhodovať. Podmienkou rešpektu nemá byť priznanie dôvodu, ktorý lekára uspokojí.

## Rozdiel medzi motiváciou a funkčným overením

Možno chrániť súkromný dôvod a súčasne preukázať porozumenie stavu, rizikám a možnostiam. Ak pacient nechce hovoriť o osobných okolnostiach, overujeme aspoň jeho porozumenie stavu, rizikám a možnostiam. Keď odmietne všetku komunikáciu, vzniká neistota, nie automatický dôkaz spôsobilosti ani nespôsobilosti. Treba hľadať iný spôsob overenia a primeranú odbornú pomoc.

## Ani preukázaná neúprimnosť nevytvára súhlas

Ak existujú konkrétne rozpory alebo dôkazy vedomého zavádzania, možno ich vecne zaznamenať. Nemožno z nich odvodiť súhlas s výkonom. Posudzujeme aj to, či zamlčanie významne ohrozuje bezpečnosť, napríklad pri neoznámenom užití liekov. Naším cieľom je bezpečné rozhodnutie, nie morálne víťazstvo nad pacientom.

## Právo odmietnuť a dôsledky neúplných informácií

Lekár môže otvorene vysvetliť, čo bez potrebných údajov nedokáže bezpečne odporučiť alebo vykonať. To nie je trest, ak ide o skutočnú odbornú hranicu. Zostáva povinnosť ponúknuť dostupnú pomoc, ktorú možno bezpečne poskytnúť, pomenovať neistotu a nepredstierať poznanie skrytého motívu.

> **Užitočné pozvanie**
> Osobný dôvod mi nemusíte povedať. Potrebujem však vedieť, či rozumiete tomu, čo vám hrozí, a čo z navrhovanej pomoci dnes prijímate.

III. Keď sa súhlas zmení

# Nepriateľstvo a rozpad dôvery

Nepriateľské správanie môže byť prejavom ohrozenia, poruchy vedomia alebo zámerného útoku. Zdravotníci ho nemajú odmeňovať ani trestať. Majú ho bezpečne zvládnuť a odlíšiť od otázky súhlasu.

## Nevstupovať do súboja o pravdu

Veta, že pacient klame, často uzavrie poslednú možnosť spolupráce. Presnejšie je pomenovať rozdiel: v dokumentácii je zaznamenaný súhlas, pacient ho dnes popiera alebo odvoláva. Obe okolnosti môžu byť pravdivo opísané bez okamžitého rozhodnutia o jeho úmysle. Dokumentáciu možno ukázať na objasnenie, nie ako zbraň.

## Vytvoriť pokojné podmienky

Pomáha jeden hovoriaci zdravotník, odstup, súkromie, krátke vety a primeraný čas. Pokiaľ to stav dovoľuje, ponúkneme prestávku alebo iného lekára. Prítomnosť viacerých autorít pri lôžku môže v pacientovi vyvolať pocit obkľúčenia. Pri možnom nátlaku blízkej osoby je vhodný samostatný rozhovor. [5, 6]

## Pevná hranica správania

Nesúhlas je prípustný; vyhrážanie a fyzické napádanie nie sú. Ochrana personálu a ostatných pacientov je legitímna. Pri bezprostrednom ohrození treba postupovať podľa závažnosti a platných pravidiel pracoviska. Opatrenie na zaistenie bezpečnosti však samo osebe nenahrádza súhlas s dialýzou či iným somatickým výkonom.

## Pozor na vlastnú reakciu

Popretie rozhovoru môže lekár prežívať ako obvinenie z nepoctivosti. Potom ľahko začne brániť seba namiesto riešenia stavu. Je správne chrániť profesijnú povesť presným záznamom a prítomnosťou kolegu. Nie je správne premeniť liečbu na skúšku pacientovej lojality.

> **Dve hranice naraz**
> Rešpektujeme právo odmietnuť výkon. Súčasne vyžadujeme bezpečné správanie. Jedno právo neruší druhú povinnosť.

III. Keď sa súhlas zmení

# Ako obnoviť rozhodovanie po konflikte

Neriešime iba to, kto si správne pamätá minulosť. Potrebujeme poznať aktuálny stav a vôľu pacienta a určiť, aký ďalší postup je právne prípustný.

## 1. Zastaviť automatické pokračovanie

Pri jasnom odpore nepostupujeme iba na základe starého podpisu. Overíme, či pacient súhlas odvoláva, či ide o strach z konkrétneho kroku alebo o poruchu komunikácie. Ak výkon práve prebieha, zohľadníme aj bezpečnosť jeho prerušenia. Pri neodkladnosti súčasne posudzujeme, či sú splnené podmienky zákonnej výnimky; samotná potreba rýchleho výkonu nestačí. [1]

## 2. Znovu posúdiť stav a rozhodovaciu schopnosť

Porovnáme dnešnú pozornosť, pamäť a správanie s predchádzajúcim stavom. Hľadáme liečiteľné príčiny a overíme porozumenie v krátkych úsekoch. Naliehavosť môže skrátiť čas na posúdenie, nie však odstrániť povinnosť zohľadniť známu vôľu pacienta a overiť oprávnenie zasiahnuť. Pri pochybnostiach prizveme skúseného kolegu či príslušné konzílium.

## 3. Dať priestor novej voľbe

Netreba dosiahnuť priznanie, že minulý súhlas skutočne zaznel. Ak pacient dnes dokáže rozhodovať, vysvetlíme aktuálnu ponuku od začiatku a overíme rozsah voľby. Ak porozumenie zlyháva alebo vôľu nemožno spoľahlivo zistiť, výslovne zdokumentujeme, čo zostáva nejasné. Rodinný podpis tento problém automaticky nevyrieši.

## 4. Uzavrieť konkrétny plán

Výsledkom nemá byť iba zápis o nespolupráci. Má byť zrejmé, čo sa poskytuje, čo pacient odmieta, ako sa sleduje vývoj a kedy sa hodnotenie zopakuje. Druhý lekár nie je nástroj na prehlasovanie pacienta; môže nezávisle overiť klinickú situáciu a znížiť riziko vzájomnej zaujatosti.

> **Veta pre rozhovor**
> Pred dvoma dňami sme zaznamenali váš súhlas. Dnes hovoríte nie. Nebudem vás nútiť prijať našu spomienku; potrebujeme si ujasniť, čo chcete teraz a či rozumiete následkom.

III. Keď sa súhlas zmení

# Dokumentácia bez čítania myšlienok

Dobrý záznam chráni pacienta aj tím, pretože oddeľuje udalosť od jej výkladu. Nálepka nenahradí opis.

## Minulosť a prítomnosť osobitne

Uvedieme dátum a čas pôvodného poučenia, jeho obsah, vtedajšie vyjadrenie pacienta a prítomné osoby. Osobitne zaznamenáme nový rozhovor, aktuálny stav a aktuálne rozhodnutie. Starší záznam spätne neprepisujeme tak, aby zmizol rozpor. Prípadné doplnenie musí zostať rozpoznateľné a časovo určené.

## Pozorovanie namiesto rozsudku

Namiesto slov manipulatívny pacient uvedieme napríklad, že popiera konkrétny rozhovor, odmieta vysvetliť dôvod a napriek novému poučeniu odmieta výkon. Pri agresii opíšeme slová alebo konanie podstatné pre bezpečnosť. Pri posúdení porozumenia zaznamenáme obsah odpovedí, nie iba všeobecné tvrdenie, že pacient bol poučený.

## Neistota patrí do záznamu

Ak motiváciu nepoznáme, uvedieme to. Ak je podozrenie na delírium, zapíšeme konkrétne prejavy a plán overenia. Ak posúdenie nebolo možné pre odmietnutie komunikácie, neskrývame to za automatický záver. Svedok dokladá, čo počul alebo videl; jeho prítomnosť sama nedokazuje rozhodovaciu schopnosť ani platnosť súhlasu.

## Ilustračné znenie, nie univerzálny formulár

Pacient dnes popiera predchádzajúce poučenie a odmieta navrhovaný výkon. Dôvod neuvádza. Opätovne vysvetlené aktuálne riziká a možnosti. Nasleduje konkrétny opis jeho odpovedí, zistení pri posúdení rozhodovania, rozsahu odmietnutia, prítomných osôb a dohodnutého postupu. Takýto záznam musí vždy obsahovať skutočné zistenia; nemožno ho prevziať ako hotový dôkaz. [1, § 6 ods. 10]

> **Čo záznam nedokáže**
> Podpis nevytvorí porozumenie. Presný záznam však umožní neskôr posúdiť, aké informácie a možnosti boli pacientovi skutočne poskytnuté.

IV. Právny a vzťahový rámec

# Ohrozenie života neruší všetky hranice

Neodkladnosť vysvetľuje, prečo treba konať rýchlo. Sama osebe ešte nevysvetľuje, prečo smieme konať proti konkrétnej vôli pacienta.

## Všeobecné pravidlo a výnimka

Zákon č. 576/2004 Z. z. vyžaduje informovaný súhlas, ak neustanovuje inak. Pri neodkladnej starostlivosti podľa § 6 ods. 9 písm. a) sa súhlas nevyžaduje, ak ho nemožno včas získať, ale možno ho predpokladať. Dôležité sú obe podmienky. Nemožnosť získať súhlas a informované odmietnutie nie sú totožné. [1]

## Keď pacient neskôr stratí vedomie

Predchádzajúce relevantné odmietnutie nemožno jednoducho vymazať stratou vedomia. Treba posúdiť, čo pacient odmietol, pri akých informáciách a či to platí pre dnešnú situáciu. Článok 9 Oviedskeho dohovoru vyžaduje prihliadať na skôr vyslovené priania. Nezavádza tým však sám podrobný slovenský systém záväzných formulárov pre všetky budúce okolnosti. [2]

## Duševná porucha nie je skratka

Zákon pozná osobitnú výnimku pri splnení podmienok súvisiacich s duševnou chorobou alebo príznakmi duševnej poruchy a ohrozením či vážnym zhoršením stavu. Nemožno ju odvodzovať z nepríjemnosti pacienta. Pri príslušnom prevzatí do ústavnej starostlivosti sa uplatňuje aj súdna kontrola podľa § 9. Nedobrovoľná hospitalizácia sama neznamená neobmedzené oprávnenie na každý somatický zásah. [1]

## Etická téza a konkrétny právny postup

Medzinárodné etické dokumenty podporujú právo dospelého človeka schopného rozhodovať odmietnuť aj život zachraňujúcu liečbu. Pri konkrétnom konflikte však treba určiť právny režim, rozsah výkonu a dostupné ochranné postupy. Britské hodnotiace rámce a americké nefrologické odporúčania nie sú náhradou slovenského práva. [3, 4, 7]

> **Právny stav dokumentu**
> Použité slovenské znenie zákona č. 576/2004 Z. z. je účinné od 1. augusta do 30. decembra 2026. Právne zdroje boli overované k 24. októbru 2026.

IV. Právny a vzťahový rámec

# Rodina: blízkosť nie je automatická právomoc

Rodina môže pomôcť pacientovi hovoriť vlastným hlasom. Môže ho však aj prehlušiť. Jej zapojenie má podporovať rozhodovanie, nie nahradiť ho bez oprávnenia.

## Tri rôzne postavenia

Byť príbuzným, mať prístup k určitým informáciám a byť oprávnený rozhodovať nie sú totožné veci. Ak je pacient schopný rozhodovať, rodina sa zapája podľa jeho želania a pri rešpektovaní dôvernosti informácií. Jej súhlas nenahrádza jeho súhlas. Jej odmietnutie neruší jeho súhlas s liečbou. Prístup k dokumentácii má vlastné zákonné podmienky. [1, 5]

## Keď rodina ovplyvní zmenu postoja

Zmena po návšteve príbuzného môže vyvolať podozrenie na tlak. Časová súvislosť však ešte nedokazuje donucovanie. Pacient mohol dostať aj podstatnú informáciu alebo podporu. Ak je to možné, overíme jeho vôľu v samostatnom rozhovore. Pýtame sa, či môže slobodne nesúhlasiť s rodinou a či sa mu niekto nevyhráža nepriaznivými následkami.

## Zákonný zástupca je osobitná otázka

Ak zákonný zástupca odmieta dať súhlas v rozpore so záujmom osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, § 6 ods. 7 umožňuje poskytovateľovi podať návrh na súd. Do rozhodnutia možno vykonať výkony nevyhnutné na záchranu jej života. Toto ustanovenie nemožno uplatniť na odmietnutie dospelého človeka schopného rozhodovať iba preto, že jeho rozhodnutie pokladáme za škodlivé. [1]

## Nezávislá podpora

Ak rodina chýba alebo ju pacient nechce zapojiť, treba podľa možností hľadať inú podporu: sociálneho pracovníka, psychológa, dôveryhodnú osobu či duchovného na jeho želanie. Príbuzní nemajú slúžiť ako skupina, ktorá pacienta presvedčí silou počtu.

> **Hranica zapájania rodiny**
> Rodina nie je tribunálom nad pacientom. Lekár nie je povinný prijať každé jej želanie a pacient nie je povinný sprístupniť jej všetko.

IV. Právny a vzťahový rámec

# Keď blízki pomoc odmietajú

Laxnosť môže byť ľahostajnosťou, ale aj vyčerpaním či bezmocnosťou. Pred hodnotením charakteru treba zistiť, aká pomoc je v skutočnosti možná.

## Čo presne sa od rodiny očakáva?

Iné je prísť na rozhovor a iné zabezpečiť nepretržitú domácu starostlivosť, dopravu na dialýzu alebo odborné ošetrovanie. Blízki môžu mať vlastné ochorenia, prácu alebo dlhodobo narušené vzťahy. Samotná príbuznosť z nich nerobí náhradu zdravotníckeho a sociálneho systému.

## Konkrétna dohoda je lepšia než výčitka

Treba sa pýtať, čo rodina vie zabezpečiť, čo nedokáže a čo odmieta. Rozdelenie úloh má byť realistické. Prísľub neurčitej pomoci nemožno považovať za bezpečný plán prepustenia. Ak pacient pomoc potrebuje a doma ju nemá, ide o organizačný a sociálny problém, ktorý sa má výslovne riešiť.

## Keď vzniká podozrenie na zanedbávanie

Treba rozlišovať nezvládnutie starostlivosti, oprávnené odmietnutie neúnosnej úlohy a možné násilie či zanedbávanie. Postup vychádza z konkrétnych zistení a príslušných povinností, nie z pohoršenia nad tým, že rodina neprišla. Zapojenie sociálnej práce a ochranných mechanizmov má smerovať k bezpečiu pacienta, nie k potrestaniu neobľúbených príbuzných.

## Hranice morálnej povinnosti

Človek má dôvody zohľadňovať svojich blízkych a blízki majú dôvody nebyť ľahostajní. Z týchto morálnych vzťahov však automaticky nevzniká rozhodovacia právomoc ani neobmedzená povinnosť osobnej starostlivosti. Lekár má tieto rozdiely pomenovať, aj keď rodinná situácia vyvoláva silné emócie.

> **Praktický cieľ**
> Nie vynútený prejav rodinnej oddanosti, ale uskutočniteľná starostlivosť, jasné úlohy a bezpečný postup pri zhoršení.

**V. Koniec liečby a pokračovanie starostlivosti**

# Prečo je pojem pasívna eutanázia nepresný

Rovnaký vonkajší výsledok, napríklad nevykonaná dialýza a následná smrť, môže vzniknúť za zásadne odlišných okolností. Samotné nekonanie ich nevysvetľuje.

### Informované odmietnutie

Liečba môže byť účinná, ale pacient ju platne odmietne. Dôvodom jej neposkytnutia je rešpektovanie rozhodnutia a hranice oprávnenia, nie rozhodnutie lekára usmrtiť. Svetová lekárska asociácia výslovne odlišuje rešpektovanie odmietnutia od eutanázie, aj keď po odmietnutí nastane smrť. [8]

### Neindikovaná alebo neprimeraná liečba

Iná situácia nastáva, ak výkon nedokáže dosiahnuť odôvodnený cieľ alebo jeho záťaž nie je primeraná očakávanému prospechu a pacientovým cieľom. Treba presne uviesť dôvod a spôsob rozhodovania. Etické odôvodnenie nezačatia a ukončenia liečby môže byť obdobné; konkrétny slovenský právny a organizačný postup sa však musí posúdiť osobitne. [7, 9]

### Zanedbanie a úmyselné usmrtenie

Nekonanie môže byť aj pochybením, ak sa opomenie potrebná, oprávnená a uskutočniteľná pomoc. Pri úmyselnom usmrtení je smrť cieľom alebo zvoleným prostriedkom. Nemožno preto považovať všetky prípady bez výkonu za nevinné ani ich všetky označiť za eutanáziu. Rozhodujú povinnosť, indikácia, vôľa, zámer a okolnosti.

### Presnejší jazyk chráni uvažovanie

Namiesto súhrnnej nálepky uvedieme, ktorý výkon sa nezačal alebo sa ukončil, prečo, na základe čieho rozhodnutia a aká starostlivosť pokračuje. Tento spis nerozoberá trestnoprávnu kvalifikáciu jednotlivých konaní. Rozlišuje pojmy, ktorých zamenenie by skreslilo etické aj klinické posúdenie.

> **Päť otázok**
> Aký výkon? Aká indikácia? Aká vôľa pacienta? Aký zámer konania? Aká pokračujúca starostlivosť?

V. Koniec liečby a pokračovanie starostlivosti

# Úľava nie je opustenie

Rozhodnutie nepodstúpiť život predlžujúci výkon nesmie automaticky znamenať stratu liečby bolesti, dýchavice, úzkosti alebo základnej ľudskej pozornosti.

## Starostlivosť sa nekončí jedným nie

Treba presne dohodnúť, čo pacient prijíma: monitorovanie, liečbu príznakov, dočasné opatrenia, ošetrovateľskú starostlivosť, prítomnosť blízkych či ďalší rozhovor. Rozhodnutie o neresuscitovaní sa týka resuscitácie pri zástave obehu, nie automaticky dialýzy, antibiotík alebo všetkých ostatných zásahov. Každý cieľ a obmedzenie potrebujú vlastné objasnenie.

## Paliatívny prístup a akútne odmietnutie

Úľava od utrpenia patrí aj pacientovi, ktorý pokračuje v aktívnej liečbe. Samotné odmietnutie účinného výkonu však ešte nedokazuje terminálne ochorenie ani márnosť liečby. Neprijateľné by bolo označiť pacienta za paliatívneho iba preto, že s nami nespolupracuje. [1, § 2; 7]

## Sedácia potrebuje samostatnú indikáciu

Paliatívna sedácia smeruje k úľave od inak nezvládnuteľného utrpenia primeraným ovplyvnením vedomia, nie k odstráneniu nesúhlasu. Benátska deklarácia opisuje hlbokú sedáciu v závere života ako krajnú možnosť pri závažných nezvládnuteľných príznakoch, so súhlasom a dokumentáciou. Širší pojem paliatívnej sedácie nemožno zamieňať s nepretržitou hlbokou sedáciou až do smrti. [9]

## Úmysel treba preveriť aj v postupe

Vyhlásenie, že sme chceli iba pomôcť, nestačí. Potrebná je správna indikácia, primerané dávkovanie, sledovanie účinku a záznam. Sedácia pacienta s cieľom umožniť výkon, ktorému sa bráni, je inou otázkou než paliatívna sedácia; vyžaduje samostatné oprávnenie a nemožno ju ospravedlniť iba odvolaním sa na úľavu.

> **Nezamieňať**
> Odmietnutie dialýzy nie je samo osebe indikáciou na sedáciu. Nepriateľské správanie nie je dôvodom na paliatívnu sedáciu vôbec.

VI. Nefrologické situácie

# Tri situácie, tri odlišné rozhodnutia

Modelové príklady ukazujú štruktúru problému. Nie sú opisom konkrétneho pacienta ani univerzálnym návodom na vynútenie či ukončenie liečby.

### A. Účinná dialýza a informované odmietnutie

Pacient s nebezpečnou hyperkaliémiou rozumie riziku, dokáže ho vztiahnuť na seba a dobrovoľne odmieta dialýzu. Dialýza tým nie je márna. Treba overiť rozhodovanie, presne objasniť rozsah odmietnutia a ponúknuť medicínsky vhodné možnosti, ktoré prijíma. Nemusí odmietať všetky dočasné opatrenia. Ich účinok a obmedzenia treba vysvetliť bez predstierania rovnocennosti.

### B. Odmietanie pri delíriu

Pacient nedokáže udržať informáciu, kolíše jeho pozornosť a nerozumie dôsledkom. Nie je správne automaticky uzavrieť, že ide o platné odmietnutie. Treba súčasne posúdiť príčinu, neodkladnosť, známu vôľu, primeranosť a právny základ zásahu. Samotná možnosť, že dialýza zlepší myslenie, nie je všeobecným oprávnením vykonať ju násilím. [1, 4, 6]

### C. Neistý prospech a súhlas so skúškou

Pri neistej prognóze možno ponúknuť časovo ohraničenú skúšku liečby. Vopred treba dohodnúť cieľ, obdobie a spôsob prehodnotenia. Odporúčania RPA tento postup opisujú, ale nejde o aktuálny slovenský právny protokol. Skúška nie je pascou, z ktorej pacient nesmie vystúpiť. [7]

### Keď liečbu nemožno bezpečne uskutočniť

Vytrhávanie cievnych vstupov alebo fyzický odpor môžu ovplyvniť uskutočniteľnosť liečby aj pomer jej prínosu k riziku. Tento problém treba oddeliť od trestania za správanie. Posudzuje sa bezpečnosť pacienta i personálu, dostupné menej obmedzujúce možnosti a právne oprávnenie. Nedostatok spolupráce sám neurčuje záver o márnosti.

> **Nefrologické rozlíšenie**
> Odmietnutie účinnej liečby, porucha rozhodovania a neprimeranosť liečby sú tri odlišné problémy. Môžu sa prekrývať, ale nesmú sa zamieňať.

VII. Metafyzické jadro

# Komu patrí život?

Slovo vlastníctvo je pri živote zvodné, ale neúplné. Moje telo nie je vecou nemocnice; zároveň môj život nie je izolovanou udalosťou bez vzťahov.

## Život ako predmet odbornej správy

Keď medicínu chápeme iba ako ochranu biologických funkcií, pacient sa môže stať prekážkou úspechu vlastnej liečby. Tento pohľad má silu pri neodkladnej záchrane, no je nebezpečný ako úplný obraz osoby. Živý organizmus a človek, ktorý svoj život prežíva, sú dve perspektívy na tú istú bytosť; druhú nemožno vypustiť.

## Život ako výlučne súkromná vec

Opačný extrém prehliada vzťahy. Rozhodnutie zomrieť alebo prijať riziko smrti zasahuje blízkych aj zdravotníkov. Tieto dôsledky vytvárajú dôvody na vážny rozhovor. Nedávajú však ostatným automatické vlastnícke právo k telu pacienta. Morálna výzva nie je to isté ako oprávnenie donútiť.

## Posvätnosť života a primeranosť prostriedkov

Aj presvedčenie o vysokej či posvätnej hodnote života možno odlíšiť od povinnosti použiť každý dostupný technický prostriedok. Prijatie konečnosti nemusí byť pohŕdaním životom. A rešpektovanie slobody nemusí znamenať, že všetky pacientove rozhodnutia považujeme za rovnako dobré. Ide o odlišné otázky hodnotenia a oprávnenia.

## Dôstojnosť pred úspechom

Dôstojnosť nemá byť odmenou za rozumné správanie, spoluprácu alebo vďačnosť. Patrí aj človeku, ktorý nás uráža, mení názor alebo nevie vysvetliť svoje konanie. To neruší hranice bezpečnosti ani odbornosti. Bráni to tomu, aby sa človek stal menej hodným starostlivosti len preto, že je náročný.

> **Filozofické východisko**
> Chrániť život, rešpektovať osobu a neopustiť trpiaceho sú súvisiace záväzky. Žiadny z nich nemožno bez zvyšku nahradiť ostatnými.

VII. Metafyzické jadro

# Tá istá osoba, iná vôľa

Rozpor medzi včerajším áno a dnešným nie otvára otázku osobnej identity v čase. Staršie rozhodnutie má váhu, ale žijúca osoba nie je archívom svojich minulých výrokov.

## Kontinuita neznamená nemennosť

Osobná totožnosť umožňuje pripísať človeku včerajšie rozhodnutie. Neznamená však, že sa musí navždy riadiť rovnakou voľbou. Súhlas s liečbou nie je sľubom, ktorým sa vzdáva práva na zmenu. Žiadosť o vysvetlenie rozporu môže byť primeraná; vynútenie stálosti nie.

## Ktorá vôľa je autentická?

Nemáme právo vybrať si za pravú tú verziu pacienta, ktorá nám vyhovuje. Ak je dnešná voľba človeka schopného rozhodovať slobodná a informovaná, jej odlišnosť ju nezneplatňuje. Ak dnešné rozhodovanie narušilo delírium, staršie konkrétne priania získavajú iný význam. Rozhoduje posúdenie aktuálnej schopnosti rozhodovať a toho, či sa staršie priania vzťahujú na terajšiu situáciu, nie výber sympatickejšieho výroku.

## Pamäť a autorstvo života

Človek potrebuje určitý príbeh o sebe, ale môže ho meniť, skracovať alebo pred ním uhýbať. Popretie rozhovoru preto možno skúmať aj ako obranu identity: nechce byť človekom, ktorý už prijal závislosť, bojí sa priznať strach alebo si chráni pocit samostatnosti. To sú možné interpretácie, nie zistené diagnózy konkrétneho pacienta.

## Hranica poznania druhého

Lekár môže spoznať stav a veľkú časť dôvodov, no nikdy nemá úplný prístup k cudziemu vnútru. Etika vyžaduje určitú zdržanlivosť pri tvrdení, že presne vieme, čo pacient v skutočnosti chce. Neznáma motivácia nás nezbavuje povinnosti preverovať riziko; zbavuje nás iba oprávnenia predstierať istotu.

> **Otázka identity**
> Rešpektujem dnešného človeka, alebo od neho vyžadujem, aby zostal verný tej podobe seba, s ktorou sa mi lepšie spolupracovalo?

VII. Metafyzické jadro

# Sloboda zraniteľného človeka

Autonómia sa neuskutočňuje mimo tela, strachu a vzťahov. Potrebuje podmienky, v ktorých človek môže informáciám porozumieť a rozhodnutie naozaj urobiť.

## Podpora nie je opak samostatnosti

Človek sa môže rozhodovať samostatnejšie práve vďaka dôveryhodnému vzťahu, úľave od bolesti či pomoci pri doprave. Odstránenie prekážky môže mať väčší význam než ďalší argument. Vzťahová autonómia v tomto spise označuje filozofické chápanie slobody podporenej vzťahmi, nie právo rodiny rozhodovať namiesto pacienta.

## Nie každé odmietnutie je slobodné

Ak pacient odmieta pre vydieranie, nesprávnu informáciu alebo neschopnosť spracovať dôsledky, nestačí formálne uznať jeho výrok. Na druhej strane nemožno žiadať rozhodnutie úplne zbavené strachu a všetkých vplyvov. Takto nerozhoduje nikto. Potrebujeme dostatočne slobodné a informované rozhodovanie v reálnych podmienkach.

## Dôvera bez naivity

Pacient môže zatajiť údaj, poškodiť dôveru alebo sa správať nepoctivo. Lekár nemusí poprieť, čo zistil. Nemusí však poznať všetko, aby zachoval profesionálnu spravodlivosť. Dôvera v medicíne nie je slepá viera v každý výrok. Je to aj ochota nevytvárať si úplný obraz o človeku na základe jediného prípadu zavádzania.

## Telo ako posledná hranica kontroly

Odmietnutie môže byť posledným miestom, kde pacient prežíva vlastnú moc. Ak odpovieme iba mocou inštitúcie, môžeme jeho odpor ešte posilniť. Ak však z obavy pred nátlakom ignorujeme delírium či násilie blízkej osoby, tiež zlyháme. Citlivosť musí zostať spojená s konkrétnym posudzovaním.

> **Dvojitá kontrola**
> Nenazývame autonómiou opustenie? Nenazývame starostlivosťou ovládnutie?

VIII. Lekár a praktická zodpovednosť

# Zodpovednosť nie je všemocnosť

Lekár zodpovedá za kvalitu svojho odborného a ľudského postupu. Nemá úplnú kontrolu nad chorobou, cudzou vôľou ani konečným výsledkom.

## Tri odlišné veci

Treba rozlíšiť zodpovednosť za vlastné konanie, vplyv na rozhodnutie a kontrolu nad výsledkom. Za vlastné konanie zodpovedáme v rozsahu svojej roly. Rozhodnutie ovplyvňujeme iba čiastočne. Výsledok často nemáme pod kontrolou vôbec. Veta, že sme mali urobiť viac, má zmysel iba vtedy, keď vieme povedať, čo konkrétne bolo primerané a dostupné.

## Hnev po odmietnutí

Opakované popieranie rozhovorov môže vyvolať frustráciu a pocit zrady. Tieto pocity sú zrozumiteľné, ale nemajú určovať indikáciu ani rozsah starostlivosti. Pomáha prizvať kolegu, rozdeliť si komunikačné úlohy a po udalosti sa k nej vrátiť v tíme. Náročný vzťah sa nemá riešiť odvetou ani osamelým hrdinstvom.

## Smútok nie je automaticky vina

Aj keď odmietnutie správne rešpektujeme, pacient môže zomrieť a jeho smrť môže lekára zasiahnuť. Emocionálna bolesť sama nedokazuje pochybenie. Rovnako právne bezproblémový postup nemusí znamenať, že sa nedalo komunikovať lepšie. Poctivý rozbor má hľadať konkrétne zlepšenie, nie iba vinníka alebo sebaistenie.

## Hranice personálu

Nikto nie je povinný znášať násilie či neobmedzené ponižovanie. Ochrana tímu a bezpečné odovzdanie starostlivosti sú legitímne. Potrebná pomoc však nesmie byť odopretá ako trest za nepríjemné správanie. Systém má podporovať rozdelenie náročnej práce, dostupnosť konzílií a kontinuitu, nie očakávať bezhraničnú odolnosť jednotlivca.

> **Meradlo po udalosti**
> Vedeli by sme obhájiť celý postup, keby sme nepoznali výsledok? Alebo hodnotíme jeho správnosť iba podľa toho, či pacient prežil?

VIII. Lekár a praktická zodpovednosť

# Postup pri akútnom konflikte

Nasledujúci rámec spája odborné a etické zásady. Nie je osobitným slovenským právnym protokolom ani náhradou rozhodnutia v konkrétnej situácii.

### 1. Naliehavosť, výkon a aktuálna vôľa

Pomenujeme hrozbu, časový priestor a očakávaný účinok. Spresníme, čo pacient odmieta a či odvoláva predchádzajúci súhlas. Pri náhlej zmene nepostupujeme automaticky ani podľa starého podpisu, ani podľa neovereného predpokladu, že dnešné odmietnutie je platné.

### 2. Rozhodovacia schopnosť a podpora

Overíme pozornosť, porozumenie, udržanie informácie a zvažovanie následkov. Hľadáme liečiteľné príčiny aj komunikačné bariéry. Zabezpečíme súkromie a podľa potreby nezávislé posúdenie. Nedostatok údajov výslovne pomenujeme. Pri neodkladnosti súčasne určujeme právny základ prípadného zásahu bez súhlasu.

### 3. Odporúčanie a alternatívy

Jasne odporučíme medicínsky vhodný postup, vysvetlíme riziká vrátane smrti a požiadame pacienta, aby vlastnými slovami vysvetlil, ako navrhovanému postupu a jeho rizikám rozumie. Ponúkneme iba skutočne vhodné alternatívy. Pri neistej prognóze a súhlase pacienta možno uvažovať o časovo ohraničenej skúške. Neznáme osobné dôvody sa neusilujeme získať výsluchom.

### 4. Bezpečnosť, plán a záznam

Zvládneme bezprostredné ohrozenie, ale bezpečnostné opatrenie nepovažujeme za náhradu súhlasu s liečbou. Dohodneme pokračujúcu starostlivosť, kontakt a podmienky prehodnotenia. Zaznamenáme čas, obsah poučenia, odpovede, konkrétne zistenia o rozhodovaní, rozsah odmietnutia a úlohu ďalších osôb. Podpis nie je náhradou procesu.

> **Výsledok nemá byť iba formulár**
> Má byť jasné, čo vieme, čo nevieme, čo pacient chce, na akom základe konáme a akú pomoc ďalej poskytujeme.

IX. Otvorené otázky

# Čo zostáva sporné?

Hlboké etické uvažovanie neodstraňuje všetky konflikty. Pomáha aspoň vedieť, o čom sa naozaj sporíme a čo by bolo potrebné zistiť.

### Je odmietnutie liečby samovraždou?

Nie automaticky. Pacient môže odmietať záťaž výkonu bez zámeru zomrieť. Môže však prežívať aj samovražednú krízu, ktorú treba aktívne posúdiť. Rozhoduje jeho stav, zámer a schopnosť rozhodovať, nie samotná možnosť smrti po odmietnutí. Ani vyslovené želanie zomrieť sa nesmie bez skúmania uzavrieť jednou nálepkou.

### Má pacient právo na každú požadovanú liečbu?

Právo odmietnuť zásah neznamená právo vynútiť si neindikovaný výkon. Odborná zodpovednosť lekára zostáva zachovaná. Rozpor medzi žiadanou a ponúkanou liečbou sa má riešiť vysvetlením, ďalším posúdením a primeranými postupmi pri konflikte, nie nepravdivou ponukou výkonu bez prospechu.

### Môžeme žiadať konzistentnosť?

Môžeme žiadať objasnenie rozporov a overovať, či pacient dokáže rozhodovať. Nemôžeme požadovať nemennosť ako podmienku práva na odmietnutie. Opakované zmeny môžu signalizovať ambivalenciu, nové informácie aj poruchu rozhodovania. Každá z týchto možností si vyžaduje iný postup.

### Ako zabrániť pohodlnému ustúpeniu?

Pred prijatím odmietnutia sa pýtame, či sme odstránili prekážky, ktoré sa dali odstrániť, a či sme si únavu tímu nepomýlili s rešpektom k pacientovi. Pred ďalším presviedčaním sa pýtame, či prináša niečo nové a či sme si vlastnú potrebu úspechu nepomýlili s pacientovým dobrom. Práve táto obojstranná sebakontrola odlišuje starostlivosť od rutinného súhlasenia aj od paternalizmu.

> **Na nedeľné premýšľanie**
> Čo by ma presvedčilo, že pacientovo odmietnutie je slobodné, aj keď s ním nesúhlasím? A čo by ma presvedčilo, že zdanlivý súhlas slobodný nebol?

Záver

# Zostať bez privlastnenia

Pacienta možno opustiť tým, že nad ním priskoro zlomíme palicu. Ale aj tým, že ho prestaneme počúvať a budeme vidieť iba telo, ktoré musíme zachrániť.

## Vytrvalosť bez násilia

Dobrá medicína je dôrazná pri vysvetľovaní rizika, pozorná pri posudzovaní rozhodovania a poctivá v neistote. Nezamieňa nesúhlas s poruchou ani neprehliada poruchu zo strachu, že bude pôsobiť paternalisticky. Vie opakovať rozhovor, keď sa môže niečo objasniť. Vie ho aj prestať opakovať, keď zostáva už iba tlak.

## Pravda bez potreby ponížiť

Ak pacient poprie minulý súhlas, netreba predstierať, že sa nič nestalo. Treba zachovať presný záznam a znovu overiť stav. Ale nie každú nezhodu musíme vyriešiť priznaním viny. Niekedy stačí obnoviť schopnosť hovoriť o prítomnosti. Pacient nemusí prijať našu verziu minulosti, aby dostal primeranú pomoc.

## Pokora bez rezignácie

Nepoznáme všetky motívy a neovládame každý výsledok. To nie je ospravedlnenie nezáujmu. Je to dôvod sústrediť sa na to, za čo skutočne zodpovedáme: odbornú kvalitu, pravdivosť, podporu slobodného rozhodovania, bezpečnosť a kontinuitu. Dôstojnosť človeka sa nekončí tam, kde končí jeho spolupráca.

## Posledná otázka

Keď už nesmieme alebo nedokážeme uskutočniť určitý výkon, zostáva priestor na inú pomoc. Nie je to menejcenný zvyšok medicíny. Je to skúška, či sme sa od začiatku starali o človeka, alebo iba o úspech nášho postupu.

> **Čo pre vás ešte môžeme urobiť?**
> Táto otázka nemá zrušiť hranice. Má zabezpečiť, aby sa hranica jedného zásahu nestala koncom ľudskej starostlivosti.

Pojmy a spôsob čítania

# Slovníček

### Autonómia

Schopnosť a oprávnenie človeka rozhodovať o sebe pri primeranej informovanosti, dobrovoľnosti a podpore. Nie je synonymom úplnej nezávislosti od iných.

### Rozhodovacia schopnosť

Klinické posúdenie schopností potrebných na konkrétne rozhodnutie v konkrétnom čase. Nie je automaticky totožná so spôsobilosťou na právne úkony.

### Informovaný súhlas a jeho odvolanie

Súhlas založený na poučení a dobrovoľnom rozhodnutí. Predchádzajúci podpis sám osebe neprelamuje neskoršie platné odmietnutie.

### Delírium

Akútna a často kolísavá porucha pozornosti a ďalších poznávacích funkcií. Môže meniť správanie i rozhodovanie; samotná nepríjemnosť ju nedokazuje.

### Primeranosť liečby

Vzťah očakávaného prospechu a záťaže vzhľadom na klinický stav a pacientove ciele. Nie je totožná iba s technickou vykonateľnosťou.

### Márnosť liečby

Pojem vyžadujúci presne uvedený cieľ, ktorý liečba nedokáže dosiahnuť. Nemá označovať trest za odmietanie alebo náročné správanie.

### Nepriateľské správanie

Opis správania, ktorý treba konkretizovať. Nie je samo osebe psychiatrickou diagnózou ani dôkazom skrytého úmyslu.

### Známa vôľa a predchádzajúce prianie

Údaje o hodnotách a rozhodnutiach človeka. Ich použiteľnosť závisí od konkrétnosti a vzťahu k aktuálnej situácii; starý výrok nemožno automaticky zovšeobecniť.

> **Hranice tohto spisu**
> Klinické postupy sú odbornou syntézou. Právne ustanovenia sú oddelené od medzinárodných etických odporúčaní. Samostatný aktuálny slovenský algoritmus pre neresuscitovanie a paliatívnu sedáciu tu nie je prezentovaný ako overený. Filozofické interpretácie motivácie nie sú diagnózami.

**Pramene a odborné podklady**

# Pramene

Číselné odkazy v texte odkazujú na nasledujúce položky. Názvy sú klikateľné. Pramene boli overované 23. a 24. októbra 2026.


### [1] Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

Časová verzia účinná od 1. 8. do 30. 12. 2026. Najmä § 4, § 6, § 9, § 11 a § 25. Slovenský právny rámec súhlasu, odmietnutia, dokumentácie a zákonných výnimiek.

### [2] Dohovor o ľudských právach a biomedicíne

Oznámenie MZV SR č. 40/2000 Z. z. Najmä články 5, 8, 9 a 10. Súhlas, neodkladnosť, predchádzajúce priania a súkromie.

### [3] World Medical Association: Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient

Medzinárodný etický dokument. Právo dospelého schopného rozhodovať prijať alebo odmietnuť liečbu; kontinuita a dôstojnosť starostlivosti.

### [4] NICE NG108: Decision-making and mental capacity

Odporúčania, 2018. Podpora a hodnotenie rozhodovacej schopnosti. Britský právny kontext nemožno zamieňať za slovenský.

### [5] NICE NG197: Shared decision making

Odporúčania, 2021. Spoločné rozhodovanie, komunikácia rizík, overovanie porozumenia a zapájanie blízkych podľa želania pacienta.

**Pramene a odborné podklady**

# Odborné podklady

Číselné odkazy v texte odkazujú na nasledujúce položky. Názvy sú klikateľné. Pramene boli overované 23. a 24. októbra 2026.


### [6] NICE CG103: Delirium: prevention, diagnosis and management in hospital and long-term care

Odporúčania, 2010; aktualizácia 18. 1. 2023. Náhle zmeny a kolísanie stavu, hodnotenie delíria a hľadanie príčin.

### [7] Renal Physicians Association: Shared Decision-Making in the Appropriate Initiation of and Withdrawal from Dialysis

2. vydanie, 2010. Overený súhrn odporúčaní pre dospelých, najmä odporúčania 5 až 9. Starší americký odborný rámec, nie slovenský právny protokol.

### [8] World Medical Association: Declaration on Euthanasia and Physician-Assisted Suicide

2019. Vymedzenie eutanázie a odlíšenie rešpektovania odmietnutia liečby od úmyselného usmrtenia.

### [9] World Medical Association: Declaration of Venice on End of Life Medical Care

Revízia 2022. Primeranosť starostlivosti na konci života, autonómia, úľava a podmienky hlbokej sedácie pri nezvládnuteľných príznakoch.


**Ako pracovať s prameňmi**

Slovenský zákon a dohovor zakladajú právny rámec; WMA poskytuje medzinárodné etické stanoviská. NICE prináša britské klinické odporúčania a RPA starší americký nefrologický rámec. Rozhodnutie v konkrétnej situácii potrebuje aktuálne klinické posúdenie a miestne právne a organizačné podmienky.